

ヘルスケア文献における「Goals of Care」の われ方と意味 — 系統的レビューと質的談話分析

出典 Secunda K, Wirpsa MJ, Neely KJ, Szmuiłowicz E, Wood GJ, Panozzo E, McGrath J, Levenson A, Peterson J, Gordon EJ, Kruser JM. J Gen Intern Med. 2020;35(5):1559-1566. DOI: 10.1007/s11606-019-05446-0

掲載誌 Journal of General Internal Medicine(2019-10-21)

原著 doi.org/10.1007/s11606-019-05446-0(本文PDFは別途)

原題 Use and Meaning of \"Goals of Care\" in the Healthcare Literature: a Systematic Review and Qualitative Discourse Analysis

🔗 共有ページ(リンクを知る人は誰でも閲覧可): <https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/s11606-019-05446-0.html>

聖路加ICUでの実践への示唆

- **家族面談の設計に4要素を持ち込む**: 面談を「DNARを取る場」にせず、GOCの操作的定義の4要素(包括的目標／患者の価値観／臨床的文脈／介入判断)を順に踏む構造にする。とくに**最初に価値観、最後に介入判断**の順序を崩さない。Scheunemannの「4%」を自分たちの面談で繰り返さないための具体的な歯止めになる
- **カルテ記載の言葉を変える**: 「GOC=DNAR」のショートカット記載をやめ、「患者が大切にしていること(価値観)」「現在の臨床的文脈でのその実現可能性」「そこから導かれる介入方針」を分けて書く。当科のカルテ文化を、Kruserが指摘した「予後不良・対立・治療制限の口実」から患者中心へ寄せる
- **多職種で目標の優先順位づけを共有する**: GOCは動的で、目標間にトレードオフがある。回診・カンファで「今この患者の目標は何が優先か」を看護・PT/OT・MSW・チャブレンと明示的にすり合わせる。二分法(延命 ⇄ 快適さ)に落とし込まず、包括的アプローチ(自宅退院・自立・家族行事など)を選択肢として言語化する
- **臨床医自身のバイアスを議題にする**: 「自分のGOCと患者のGOCが乖離していないか」をカンファの問いに加える。医師の価値判断が治療制限の推進力になっていないかを、チームで点検する文化をつくる

- **教育への接続**: 初期研修医・専攻医に「この検査／治療は患者のGOC達成を助けるか」という問いを、検査オーダー時の「結果は方針を変えるか」と同じ反射として教える。聖路加ICUマニュアル(金芳堂)のコミュニケーション章の骨子に使える

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known(既に分かっていたこと)**: 「Goals of Care(GOC)」は重症患者ケアで日常的に使われる用語で、緩和ケア関連の他の用語(actively dying、end of life、palliative care など)は先行の系統的レビューで概念定義が整備されてきた。
- **Unknown(分かっていたいなかったこと)**: GOC 自体は広く使われる割に意味が曖昧で、文献の合意に基づく操作的定義(誰が使っても同じ意味になる実務的定義)が存在しなかった。臨床現場での実際の使われ方と定義の関係も未整理だった。
- **What's new(本研究の新規性・意義)**: 1987～2018年の文献214本を質的談話分析にかけ、GOC を「患者の価値観と優先順位に基づき、現在の臨床的文脈のなかで定められ、個別の医療介入を使うか差し控えるかの判断を導く、医療の包括的な目標」と操作的に定義した。あわせて、臨床現場では GOC が予後不良の婉曲表現や治療制限の口実として使われ、家族面談で患者の価値観に触れる発話が4%未満という文献定義との乖離を示した。

全体要約

要旨

この論文が答えたこと「Goals of Care (GOC、ケアの目標)」という言葉は重症患者ケアの現場に遍在するが、**その意味は曖昧で合意された定義がなかった**。本研究は1987～2018年のヘルスケア文献214本を質的談話分析にかけ、文献の合意から**操作的定義(誰が使っても同じ意味になる実務的定義)**を抽出した。結論は「GOC＝患者の価値観と優先順位に基づき、現在の臨床的文脈のなかで定められ、個別の医療介入を使うか差し控えるかの判断を導く、医療の包括的な目標」。臨床現場ではGOCが「予後不良の婉曲表現」「治療制限の口実」として使われ、肝心の患者の価値観がほぼ語られないという乖離も指摘している。

項目	内容
デザイン	系統的レビュー + 質的談話分析 (discourse analysis)
検索	2018年10月、MEDLINE/PubMed・CINAHL・Scopus。タイトル/抄録に "goals of care" を厳密一致で検索
対象	英語文献。学会抄録は除外。出版年・形式・研究デザインの制限なし
選別	1,645本 → 全文評価290本 → 最終214本(うち90本を全文コーディング)
分析者	多職種8名(医師5・看護師1・ソーシャルワーカー1・チャプレン1)
主要な産物	GOCの操作的定義と概念モデル(4つの構成要素)
副次の知見	GOCの価値(3側面)、目標の枠組み(二分法 vs 包括)、臨床使用と文献定義の乖離
領域	集中治療・緩和ケア・意思決定・コミュニケーション(介入研究ではない)

押さえるべき5点

- 1 GOCの操作的定義は4要素からなる。**包括的な目標／患者の価値観と優先順位／臨床的文脈／医療介入の判断を導く**。この4つが揃って初めてGOCと呼べる。

- ② GOCが重要なのは3つの理由から。患者の**自律の尊重**、**望まないケアの回避**と**価値あるケアの特定**、患者・家族への**心理的支え**。
- ③ 文献は「目標の選び方」に二分法(延命 ⇄ 快適さの一次元)と包括的アプローチ(複数目標の同時追求)の2枠組みを使う。**著者らは二分法の危うさを明示的に指摘**している。
- ④ GOCは患者に帰属する(patient-centered)が、臨床医の役割が実装の中核。**引き出す・明確化する・臨床的含意を説明する・優先順位づけを助ける**。臨床医自身のバイアスが対立の火種になる。
- ⑤ 臨床現場のGOCと文献定義には乖離がある。ICU家族面談の実証研究では、医師が「GOCを話す」と宣言した場面でも、**発話語数の4%未満しか患者の意向・価値観に触れていなかった**。

詳細

まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む 重症患者や生命を脅かす病気の人へのケアでは、「この人にとって医療は結局何を指すのか」を話し合う場面が絶えず生じる。そこで使われるのが「Goals of Care(GOC、ケアの目標)」という言葉である。ところが GOC は現場に遍在する割に、意味が人によってばらつく。ある人は患者の価値観そのものを、ある人はそれを実現する治療を、ある人は延命か快適さかの選択を指して使う。曖昧な言葉は患者・家族・多職種チームのあいだに誤解と齟齬を生む。研究の面でも、「提供されたケアが患者の目標と一致しているか(goal-concordant care)」という終末期ケアの質の指標を測るには、GOCの明確な定義が土台として要る。そこで本研究は「操作的定義」＝誰が使っても同じ意味になる実務的な定義を、大量の文献の言葉づかいを質的に分析(談話分析)して抽出しようとした。得られた定義は4要素からなる(包括的な目標／患者の価値観と優先順位／臨床的文脈／医療介入の判断を導く)。この枠組みに照らすと、GOC を DNAR(心肺蘇生をしない指示)や人工呼吸の可否と同一視する狭い使い方は、文献の合意から外れた用法だと分かる。

1. 背景 — なぜ「言葉の意味」を研究するのか

「Goals of Care(GOC)」は、重症・生命を脅かす疾患をもつ患者の最善のケアを目指す臨床医・研究者・政策立案者が日常的に使う言葉である。しかし**広く使われている割に意味が曖昧で、合意された操作的定義が存在しなかった**。

著者らの先行研究(ICU入室患者の電子カルテの談話分析、Kruser 2019)では、GOCという語がカルテに遍在する一方で、その使われ方は次の3つに偏っていた。

- 予後不良を示すコミュニケーションの表現
- 臨床医・患者・家族のあいだの対立の記述
- 特定の治療を制限する根拠づけ

そして肝心の**患者・家族の具体的な目標や価値観を伝えるためにはほとんど使われていなかった**。

重症患者ケアには曖昧な言葉が多い。「seriously ill」「comfort care」「supportive care」、そして「palliative care」自体も定義が揺れている。婉曲表現や曖昧な言葉は、患者・家族・多職種チームのあいだに誤解と齟齬を生み、患者中心の意思決定・緩和ケア・終末期ケアを改善しようとする研究者にとっても障壁になる。米国NIHと米国臨床腫瘍学会(ASCO)はいずれも、終末期ケアの科学を進めるために緩和ケア用語の明確化が必要だと宣言している。

本研究の目的は2つ。ヘルスケア文献における**GOCの使われ方と意味を明らかにすること**、そして**文献の合意に基づく操作的定義を特定すること**である。

2. 方法 — 系統的レビューと談話分析

2.1 文献検索

2018年10月、医学司書が3つのデータベース(MEDLINE via PubMed・CINAHL・Scopus)で、タイトルと抄録のフィールドに "goals of care" という**厳密なフレーズ一致**で検索した。英語に限定、学会抄録は除外。GOCの使われ方そのものを調べる目的のため、**出版年・出版形式・研究デザインでの絞り込みはあえて行わなかった**。GOCの語がごく些末にしか登場しない文献、重症・生命を脅かす・生命を制限する疾患に関連しない文献は除外した。2名(KS・JMK)がRayyanで選別し、不一致は第3のレビュアー(AL)が裁定した。

2.2 選別の流れ(Figure 1)

図の解説

Figure 1 — 文献選別のフロー（PRISMA型）上から下へ4段のボックスが並び、各段から右へ除外の枝が伸びる縦型フロー。

- **1,645本** (2018年10月のデータベース検索でヒット) → 右へ **1,355本除外** (タイトル/抄録による)
- **290本** (全文で適格性を評価) → 右へ **71本除外** (全文レビューによる)
- **219本** (組み入れ候補) → 右へ **1本** (全文入手不能) + **4本** (重複) を除外
- **214本** (最終サンプル)

数の引き算が合う ($219 - 1 - 4 = 214$) 点まで含め、標準的な系統的レビューの選別図として読める。

2.3 データ抽出と質的コーディング

談話分析 (discourse analysis) とは、言葉やテキストを自然な文脈のなかで評価する手法である。GOCは明示的な定義を伴わずに使われることが多いため、この手法を用いて**言外にある根本的なテーマ**を掘り起こした。

分析は段階的に進んだ。

- まず2名 (KS・JMK) が各文献のタイトル・抄録・本文・表・図を独立に読み、GOCという語が登場するすべての箇所を特定した
- 帰納的アプローチで各箇所を独立にコーディングし、毎週集まって各箇所の合意コードを確定した
- コードは分類体系 (taxonomy) にまとめ、反復的に改訂した

最も古い文献から時系列でコーディングを開始。**最初の56本 (2012年まで) で理論的飽和に達した**。新しい文献の重要テーマを見落とさないため、目的的分層サンプリングで34本を追加抽出した (対象: 心不全・外科など従来過小に扱われた患者集団、院内急変対応など新しい場面、臨床医バイアスやカルテ記載など新規テーマ、概念モデルを明示的に報告した文献)。追加34本を飽和後もコーディングし、新テーマが出ないことを確認した。**全214本のうち90本を全文コーディングした**。

その後、多職種チーム (医師5・看護師1・ソーシャルワーカー1・チャプレン1、専門は集中治療・緩和ケア・臨床倫理) で**軸足コーディング (axial coding)**を行い、コード間の関係からテーマを生成した。少なくとも5名が参加する週1時間の会議を重ね、主要な結果に合意が得られるまで議論した。

3. 結果① — GOCの使われ方

最も古い組み入れ文献は1987年。GOCの使用はその後**顕著に増加**し(Figure 2)、**全体の87%が直近10年(2009～2018年)に出版**されていた。文献は**122の異なるジャーナル**と5つの書籍章に掲載されていた。

図の解説

Figure 2 — 「Goals of Care」を主題とする文献数の年次推移(1987～2018年) 横軸に年(1987、1995、1996…2018)、縦軸に年間の文献数(0～60)をとった折れ線。1987～2005年ごろまでは年数本で横ばい(多くの年で0～4本)。2006年ごろからゆるやかに立ち上がり、2012年以降に急峻な上り坂となって、2018年に約54本へ到達する。2018年のデータ点には「*」が付き、キャプションに「最初の8か月の実績からの年間推定値」と注記される。**GOCという概念がこの10年で急速に主流化したことを一目で示す図。**

掲載領域の内訳(多い順)：

領域	割合
緩和ケア	28.0%
内科・一般医学	16.8%
腫瘍内科	8.4%
呼吸器・集中治療	7.5%
看護	5.1%
循環器	3.7%
ヘルスサービス研究	3.7%
老年医学	3.3%
救急医学	1.9%
一般外科	1.9%
倫理	1.4%
その他(産科・プライマリケア・小児・教育)	3.9%

MEDLINE未収載のジャーナルが12.1%、書籍章が2.3%。**緩和ケア領域は全体の3分の1未満**で、GOCが緩和ケアの枠を越えて医学全般に広がっていることがわかる。

文献におけるGOCは、主に次の3カテゴリーの重症患者との／についてのコミュニケーションを指していた。

- ① 一般に予後不良とされる疾患（進行がん、認知症など）をもつ患者
- ② 疾患の種類を問わず、治癒が不可能または死が差し迫った段階に達した患者
- ③ 治癒不能・重症・生命を制限する／脅かす疾患が多い特定の場（ナースিংホーム、救急外来、ICUなど）でケアを受ける患者

さらに著者らは、**医療システムそのものが「治癒と延命」という暗黙のGOCをもっている**と指摘する。ある著者の言葉では「ヘルスケアの暗黙の目標はふつう治癒か生存であり、多くの臨床領域ではGOCは『当然のもの』とされ明示されない」。GOCが患者集団に適用されるのは典型的には、**この暗黙のシステム目標（治癒・延命）がもはや不可能・可能性が低くなった場面**である。

4. 結果② — GOCの操作的定義（本研究の中核）

談話分析から得られた合意テーマに基づき、著者らは操作的定義と概念モデル（Figure 3）を生成した。

操作的定義：「**GOCとは、患者の根底にある価値観と優先順位に基づき、現在の臨床的文脈のなかで定められ、個別の医療介入を使うか制限するかの判断を導くために用いられる、その患者に対する医療の包括的な目標である**」。

図の解説

Figure 3 — GOCの概念モデル 3つの角丸ボックスが左から右へ濃さを増す青で並ぶ。左＝薄い青「Patient Values and Priorities（患者の価値観と優先順位）」、中央＝中間の青「Goals of Care」、右＝濃い青「Intervention Decisions（介入の判断）」。ボックスのあいだは灰色の循環矢印（回転するリサイクル様のアイコン）でつながれ、一方向の直線ではなく行き来する関係を示す。下段には緑の太い矢印が左から右へ伸び、その上に「Clinical Context（臨床的文脈）」「Medical Intervention Options（利用可能な医療介入の選択肢）」の2語が乗る。読み方：**患者の価値観 → GOC → 介入の判断**という流れが、常に「臨床的文脈」と「実際に取りうる介入の選択肢」という土台の上で成り立つことを表す。価値観が介入判断に直結するのではなく、GOCという中間層を経由する点が要点。

Table 1 は、この定義を構成する4つの主要テーマを代表的な引用で示す。

主要テーマ	意味	文献での表現の例
包括的な目標	ケア全体が目指す大きな方向・到達点	「overarching」「big picture」「global」「direction」「telos(究極目的)」。「価値観の表明より具体的で、個別介入より一般的」
患者の価値観と優先順位	患者の価値観の文脈で、可能な帰結の優先順位づけを反映して形成される	「患者の価値観を反映して」「患者にとって最も大切なことの理解」
臨床的文脈	現在の病状・臨床状況の範囲内で定式化される	「appropriate」「attainable」「realistic」「reasonable」「possible」。正確な病状理解が前提
医療介入の判断	個別の介入判断とは区別されるが、それを導く枠組み	「検査を出すとき『結果は方針を変えるか』と問うように、『この治療は患者のGOC達成を助けるか』と問える」

4.1 分岐する定義(合意から外れる使われ方)

いくつかの文献は、GOCを**医療介入の判断そのものと同義**に扱う分岐的な定義を示していた。例:「GOCプランとは、現在の病態に対する治療制限を明確にする医療指示である」。他にもGOCが**心肺蘇生の可否(DNAR)、人工呼吸の判断、ICU入室の可否**と同一視される例があった。さらに一部の文献は、GOCは曖昧で明確な定義を欠くと率直に述べていた。「『GOC』はある人には患者の目標／価値観を、別の人にはそれを達成する治療を、また別の人には両方を意味する」。

5. 結果③ — GOCの価値(なぜ重要か)

文献は、重症患者にとってGOCという概念が重要・有用である理由を3つのテーマで挙げていた(Table 2)。

主要テーマ	内容	文献での表現の例
患者の自律と患者中心のケアの促進	患者の価値観に沿った事前のケア決定を助け、自律を尊重する枠組みを提供する	「治療の判断は患者のGOCに基づくべきで、それが倫理的で患者中心の意思決定の枠組みになる」
望まないケアの回避と価値あるケアの特定	不要な入院・侵襲的手技・苦痛・死のプロセスの延長を避ける	「GOCの合意欠如は、入居者が望まないケアを受けたり価値あるケアを逃したりすることにつながる」
心理的・情緒的な支え	複雑で困難な決断に直面する患者・家族の不確かさを和らげる	「治療中心でなく患者のGOCを理解する接近は、終末期ケアを改善し、重症患者家族の心理的負担も減らしうる」

5.1 目標をどう選ぶか — 二分法 vs 包括的アプローチ

「患者はどんな目標から選べるのか」という問いに、文献は2つの異なる枠組みで答えていた。

二分法(dichotomous): GOCを、一方の端を「延命」、他方の端を「快適さ(comfort)」とする一次元の連続体から選ぶ1つの主要目標として捉える。あるいは両極端の二者択一とする。例: 「快適さのみ ⇔ 生存のみの連続体で目標を評価させた」。

しかし複数の文献が二分法の危うさを明示的に指摘している。「**多くの医師はこの2つを相互排他的とみなすが、目標を単一の優先事項の枠に押し込めると、ケアを『緩和的か治癒的か』のどちらかとする見方を助長し、両者の統合を妨げる恐れがある**」。

包括的アプローチ(inclusive): 延命と快適さを越えて、より広い範囲の目標を、複数同時に追求しうるものとして許容する。具体例: 疾患予防、良い死(good death)の達成、特定の人生目標(家族行事への参加、関係の修復)、QOLの改善・維持、家族・介護者への支援、自宅で暮らすこと、自立の維持、負担に感じる介入の除去。ある文献は「医療の目標は予防から治癒、延命、良い死まで多数ありうる。複数の同時に当てはまり、どれか1つが他より重要ということはない」と述べる。

ただし二分法・包括いずれの場合も、文献は目標を**離散的・カテゴリー的な選択肢**として提示する傾向があり、開かれた無際限の概念としては扱っていなかった。

5.2 GOCの帰属と臨床医の役割

GOCの帰属・責任、患者と臨床医の関係についても複数のテーマが得られた。

- **GOCは基本的に患者に帰属する(patient-centered)**。文献は所有格を多用する(「患者のGOCを話し合いに取り込む」「患者のGOCを特定する」)

- **ただし臨床医の関わりが実装の中核。**ある文献は臨床医の4つの役割を挙げる：(1) 患者の目標を明確化し確認する、(2) その目標の臨床的含意を話し合う、(3) 関連するすべての目標が考慮されたか見極める、(4) 必要なとき目標間の優先順位をつける。他に「引き出す・言語化する・支える・理解する・伝える・解釈する・具体化する・記録する」とも表現される
- **臨床医自身が患者のGOCについて判断やバイアスをもちうる。**それが対立の火種になる。「臨床医は自分のGOCが患者・家族のGOCといつどう一致／乖離するか、乖離が問題か、何を話し合うべきかを考えるべきだ」
- **GOCは動的で時間とともに変化する。**「疾患が進むにつれ、GOCは変化し、ある目標はより強調され、ある目標は弱まる」
- **優先順位づけとトレードオフが中心概念。**「目標が複数あるとき——それはよくあることだが——目標間の対立や緊張が生じ、解決や優先順位づけが必要になる」

6. 考察 — 臨床の使い方と定義の乖離

考察の核心は、**臨床現場でのGOCの使われ方と、本研究が抽出した文献上の定義とのあいだの重要な乖離**である。

先行のカルテ談話分析(Kruser 2019)では、臨床医は予後不良・家族との対立・治療制限の根拠づけを示すためにGOCを多用する一方、**患者・家族に焦点を当てた目標・優先順位・価値観はほとんど記載していなかった。**

さらにICU家族面談の実証研究(Scheunemann 2015)では、医師が家族と「GOCを話し合う」と明示的に宣言した面談ですら、**発話語数の4%未満しか患者の意向・価値観に触れず**、患者の自律・自立・情緒的well-being・人間関係・身体機能・認知機能・スピリチュアリティのいずれかに言及した面談は**わずか12%**だった。臨床でのGOCの使い方は患者の価値観を見落としがちだが、本研究が明らかにした操作的定義は、まさに患者の価値観と優先順位を臨床的文脈のなかで引き出し適用することを土台にしている。この乖離の程度・原因・影響は未解明であり、今後の行動的介入研究の課題である。

6.1 GOC と ACP・事前指示の違い

本研究は、GOCが**アドバンス・ケア・プランニング(ACP)**や**事前指示(AD)**と関連しつつ**区別される**ことを見出した。

- **ACP:**あらゆる年齢・健康段階の成人が、将来の医療に関する価値観・人生の目標・選好を理解し共有することを支える「プロセス」
- **AD:**これらの選好を、将来の医療を指示する文書(リビングウィル、医療代理人の指定など)として形式化したもの

- **ADの限界**: 将来の状態に焦点を当てるため、いま・その場の複雑な臨床判断を支えきれないことがある
- **GOC**: これに対し、現在の具体的な臨床文脈のなかで、リアルタイムの治療判断を患者の価値観・優先順位に整合させる概念

ACPとGOCは補完的だが別物であり、両者が揃って健康～疾患の全域にわたる意思決定を支える。

6.2 研究者にとっての意義

重症患者ケアを改善する介入を設計する研究者にとって、鍵となる用語の標準化された定義は、明晰で正確な科学的コミュニケーションに不可欠である。とりわけ**goal-concordant care (目標一致ケア: 提供されたケアが患者の目標と一致している度合い)**は、質の高い終末期ケアの基本的なアウトカム指標になりつつあり、この指標は患者のGOCの明確で操作化された定義に依存する。先行の系統的レビューは「actively dying」「end of life」「palliative care」などの緩和ケア用語の概念定義を確立してきた。本研究は、新たに台頭する「goals of care」を定義することでこの流れを前進させる。

批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

- **これは介入研究ではなく、言葉の意味の研究**である。効果量もアウトカムもない。「合意に基づく操作的定義」は文献の言葉づかいの多数派を質的にまとめたものであり、その定義を使えばケアが改善するという因果の証拠は本研究にはない。定義の妥当性は今後の介入研究で検証されるべき、と著者自身が述べている
- **選択バイアス**: タイトル/抄録にGOCが「主要な焦点」として登場する文献に限定したため、GOCを副次的に扱う文献は入っていない。GOCが軽く触れられる使われ方(それも臨床の実態の一部)は捉えきれていない
- **対象の限定**: 重症・生命を制限する／脅かす疾患に関する文献に絞ったため、他の患者集団や文脈でのGOCの意味には一般化できない
- **英語文献のみ・2018年10月時点**。文化差(GOCの概念は英語圏の医療文化に強く根ざす)や、以降の急増期のデータは反映されない
- **図の内的整合**: Figure 1 のフローは $219 - 1(\text{入手不能}) - 4(\text{重複}) = 214$ で数が合う。一方、除外の内訳(タイトル/抄録1,355、全文71)と最終数の関係も $1,645 - 1,355 = 290$ 、 $290 - 71 = 219$ と辻褃が合っており、系統的レビューとしての選別は追跡可能
- **定義の「分岐」をどう扱うか**: GOCをDNAR・人工呼吸・ICU入室の可否と同一視する使い方は、著者らの合意定義では「分岐(誤用に近い)」とされる。しかし臨床現場ではこの使い方こそ日常的である。合意定義を規範として押し出すことと、現場の実態を記述することのあいだには緊張がある。JCではこの点を——「あるべき定義」か「実際の定義」か——議論に据えると深まる
- **循環の懸念**: 著者らは先行研究で「臨床医は患者の価値観を語らない」と示し、本研究で「文献の定義は患者の価値観が中心」と示した。この2つを並べると乖離の物語になるが、比較対象(臨床のカルテ／面談 vs

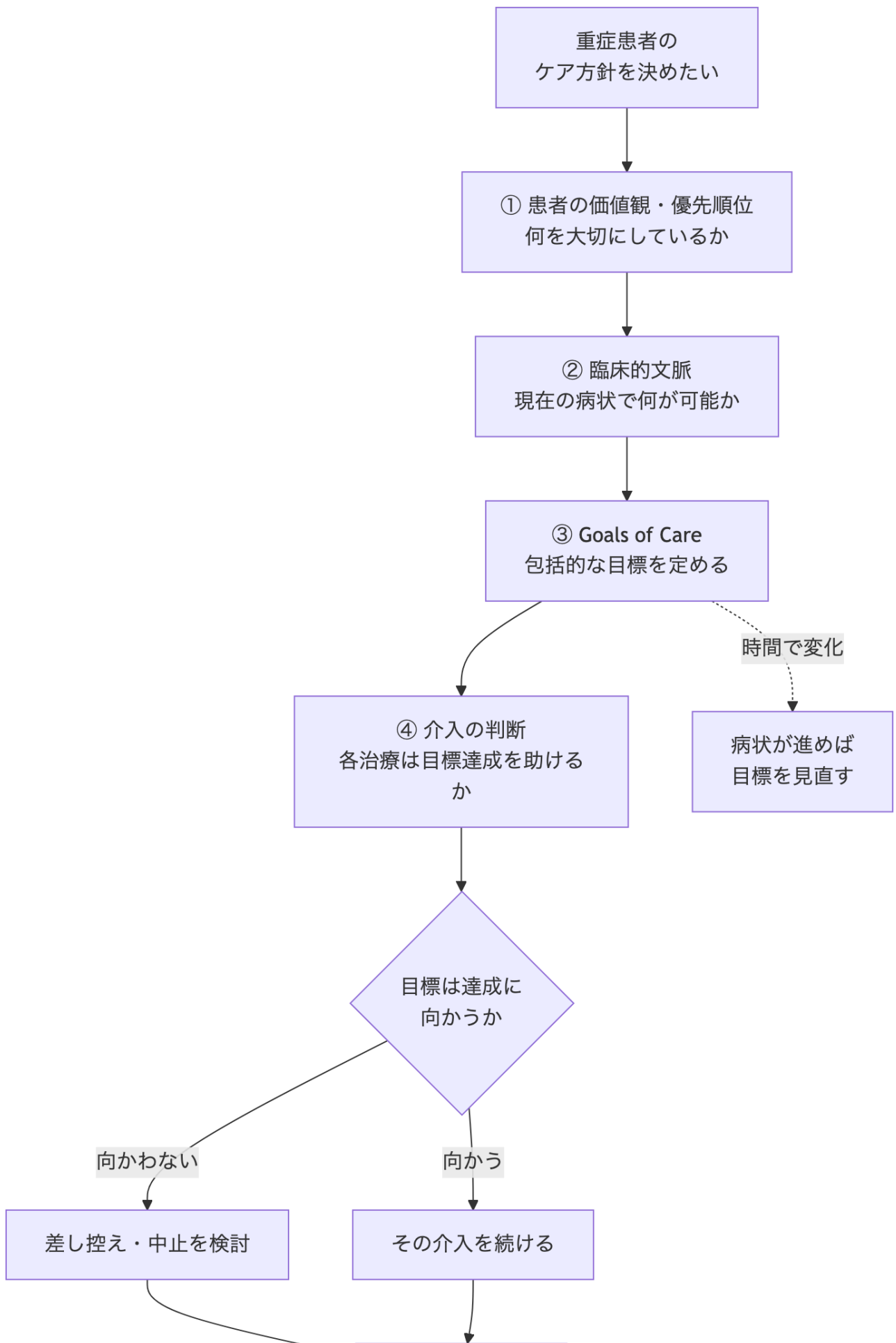
学術文献の定義)が異なる土俵である点は割り引いて読む必要がある

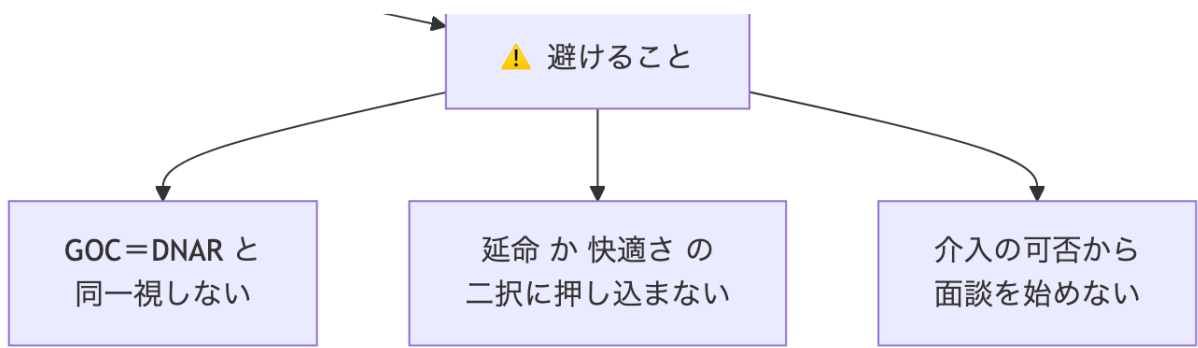
主要な引用文献

- Kruser JM, et al. Patient and Family Engagement During Treatment Decisions in an ICU: A Discourse Analysis of the Electronic Health Record. Crit Care Med. 2019 — 本研究の出発点。ICUカルテでGOCが予後不良・対立・治療制限の根拠に使われ、患者の価値観はほぼ記載されないことを示した先行研究
- Scheunemann LP, et al. How clinicians discuss critically ill patients' preferences and values with surrogates: an empirical analysis. Crit Care Med. 2015;43:757-64 — ICU家族面談で患者の意向に触れる発話が4%未満だったことを示す。考察の中核的根拠
- Sudore RL, et al. Defining Advance Care Planning for Adults: A Consensus Definition From a Multidisciplinary Delphi Panel. J Pain Symptom Manage. 2017;53:821-32 — ACPの合意定義。GOCとの区別の基準
- Hui D, et al. Concepts and definitions for "actively dying," "end of life," "terminally ill," "terminal care," and "transition of care": a systematic review. J Pain Symptom Manage. 2014;47:77-89 — 同じ手法で緩和ケア用語を定義した先行系統的レビュー。本研究の方法論的な下敷き
- Turnbull AE, et al. Goal-concordant care in the ICU: a conceptual framework for future research. Intensive Care Med. 2017;43:1847-9 — goal-concordant careをICUのアウトカム指標として位置づける枠組み
- Allen MB, Jesus JE. The language of goals of care: framing preferences at the end of life. Chest. 2012;141:1126 — 二分法的な枠組みの危険性を指摘した代表的文献

✔ Take home message

「Goals of Care」は、患者の価値観に基づき臨床的文脈のなかで定められ、個別の介入判断を導く「医療の包括的な目標」である。DNARや人工呼吸の可否と同一視するのは、文献の合意から外れた狭い使い方にすぎない。ICUの家族面談で最初に語るべきは介入の可否ではなく、患者が何を大切にしているか（価値観）である。臨床の現場では、GOCを話すと宣言してもその4%未満しか患者の価値観に触れないという乖離が実証されている。この乖離を埋めることが、聖路加ICUのコミュニケーションを患者中心に変える具体的な糸口になる。





関連

- [医学・論文](#)
- [「難治性」敗血症性ショックの前に疑うべき可逆的要因\(usual suspects フレームワーク\)](#)
- [Hotel ICU](#)
- [岡本洋史プロフィール](#)

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。